B-Well 1 y 2: ¿24 semanas de bepirovirsen logran la "curación funcional" de la hepatitis B crónica?

Hou J, Lim SG, Buti M, et al; B-Well Study Group. Phase 3 Results of Bepirovirsen Treatment for Chronic Hepatitis B Virus Infection. *N Engl J Med.* 2026;394:2395-2406. doi:10.1056/NEJMoa2515131

Versión 1.0 · Revisado el 24 de octubre de 2026 · Revisión: equipo editorial de Medicina en Resumen, contra el texto completo del artículo

¿CAMBIA LA PRÁCTICA?
Abre una opción nueva, para pocos
Aprobado por la FDA (oct 2026) en pacientes seleccionados; ~1 de cada 5 logró la curación funcional.

¿ES CONFIABLE EL RESULTADO?
Sí, para la semana 72
Dos ensayos idénticos, doble ciego, >1,800 pacientes, resultados consistentes.

LO QUE FALTA
Durabilidad y seguridad
Solo 24 semanas sin tratamiento; elevaciones de ALT, plaquetopenia y vasculitis cutánea.

En 30 segundos. Bepirovirsen es un oligonucleótido antisentido que bloquea todos los ARN del virus y además estimula la respuesta inmune. En adultos sin cirrosis, con virus suprimido por análogos de nucleós(t)idos (AN) y HBsAg de 100 a 3,000 UI/mL, 24 semanas de bepirovirsen permitieron suspender todo tratamiento y mantener HBsAg negativo con ADN indetectable 24 semanas después en **19 a 20 %**, contra 0 % con placebo. La respuesta fue mayor con HBsAg basal ≤1,000 (25–28 %).

LECCIÓN DE LECTURA CRÍTICA DE ESTA EDICIÓN
Desenlaces definidos por laboratorio y un placebo que casi no podía ganar: qué significa "curación funcional", por qué el 0 % del placebo era esperable por diseño, y qué preguntas quedan cuando la respuesta se mide solo 24 semanas después de suspender.

1 La pregunta clínica (PICO)

PACIENTES	Adultos con hepatitis B crónica **sin cirrosis**, con AN estables ≥6 meses, ADN <90 UI/mL, ALT ≤2 veces el límite superior y HBsAg >100 a 3,000 UI/mL. Excluidos: coinfección VHC, VIH o VHD; **antecedente de vasculitis o enfermedad autoinmune**; plaquetas <140,000. Solo 8 % HBeAg positivo. 29 países.
INTERVENCIÓN	Bepirovirsen 300 mg SC semanal por 24 semanas (con dosis de carga los días 4 y 11) + AN.
COMPARADOR	Placebo + AN.
DESPUÉS	AN hasta la semana 48; se suspendían solo si había HBsAg negativo y ADN indetectable de la semana 24 a la 46, ALT ≤2 veces y HBeAg negativo.
DESENLACE PRINCIPAL	**Curación funcional** a la semana 72 (24 semanas sin ningún tratamiento): HBsAg <0.05 UI/mL y ADN por debajo del límite de cuantificación, sin rescate.

2 Diseño

TIPO	Dos ensayos fase 3 idénticos (B-Well 1 y 2), doble ciego, aleatorización 2:1 estratificada por HBsAg (≤1,000 o >1,000).
TAMAÑO	1,838 aleatorizados; 1,834 recibieron al menos una dosis.
ANÁLISIS	Jerarquía fija para el primario y tres secundarios clave. Datos faltantes = no respuesta.
FINANCIAMIENTO	GSK diseñó y vigiló el ensayo, la recolección y el análisis; primer borrador escrito por un redactor médico pagado por GSK.

3 Resultados

SEMANA 72	B-WELL 1	B-WELL 2
Curación funcional (principal)	**127/650 (20 %)** vs 0/328	**106/570 (19 %)** vs 0/286
Diferencia de riesgo común (IC 95 %)	17.5 (14.6–20.3)	13.3 (10.4–16.1)
Curación funcional, HBsAg ≤1,000	25 % vs 0 %	28 % vs 0 %
Curación funcional, HBsAg >1,000	10 % vs 0 %	5 % vs 0 %
Suspendieron AN en la semana 48	159/650 (24 %)	136/570 (24 %)
ADN indetectable tras suspender AN	23 %	23 %
Anti-HBs ≥10 UI/L entre los curados (post hoc)	67 %	64 %

DATO DEL ARTÍCULO La diferencia común pondera más el estrato con HBsAg alto, donde la respuesta fue menor; por eso es menor que el porcentaje crudo. Ningún paciente con placebo suspendió los AN.

4 Cómo leer estos resultados

- **El 0 % del placebo era casi seguro.** **INTERPRETACIÓN** Solo podían suspender los AN quienes perdieran el HBsAg, algo muy raro con AN solos. El placebo funcionó como "tratamiento habitual": confirma que sin bepirovirsen prácticamente nadie llega a la curación funcional, pero la cifra que importa es el 19–20 % con el fármaco.
- **Curación funcional no es erradicación.** El ADN circular cerrado del virus persiste en el hepatocito. Es un desenlace de laboratorio que se asocia a mejores desenlaces clínicos, recomendado por AASLD, EASL y las agencias para terapias finitas.
- **24 semanas sin tratamiento es poco.** La durabilidad a la semana 96 sigue en evaluación (y en el ensayo BSure). Sin ella, no sabemos cuántos de los "curados" seguirán así.
- **La selección importa.** El beneficio se concentra en HBsAg bajo. Los autores estiman que dos tercios de los pacientes con HBsAg cuantificado tendrían ≤3,000, pero se necesita medirlo para identificarlos.

CONCEPTO CLAVE · CUANDO EL COMPARADOR NO PUEDE GANAR

INTERPRETACIÓN Si el desenlace exige algo que el comparador casi nunca logra, la significancia estadística es automática y la pregunta útil cambia: ya no es "¿es mejor que placebo?", sino **"¿cuántos responden, quiénes, por cuánto tiempo y a qué costo en efectos adversos?"**. Revisa siempre qué tan alcanzable era el desenlace para cada grupo.

5 Seguridad

SEMANAS 1–24	BEPIROVIRSEN	PLACEBO
Eventos adversos grado ≥3	**16 %**	3 %
Elevación de ALT grado 3	6 %	—
ALT ≥3 veces el límite superior	24 %	—
Reacciones en el sitio de inyección	53 %	14 %
Inflamación vascular, complemento y efectos inmunes	33 %	12 %
Plaquetas <100,000 en alguna visita	10 %	<1 %
Suspensión definitiva por eventos adversos	3 %	—

DATO DEL ARTÍCULO Las elevaciones de ALT ocurrieron sobre todo en las semanas 5 a 10, en paralelo a la caída del HBsAg, y se interpretan como marcador de respuesta. La "lesión vascular inducida por fármaco" se manifestó como vasculitis cutánea purpúrica, a veces con artralgias, que se resolvió al suspender. La TFGe y las plaquetas bajaron durante el tratamiento y volvieron casi a lo basal. Ningún caso cumplió criterios de daño hepático inducido por fármacos. "—" = no reportado en el texto principal.

6 Validez, limitaciones y aplicabilidad

ASPECTO	QUÉ REPORTA EL ARTÍCULO	ESTADO
Replicación	Dos ensayos idénticos con resultados consistentes.	Confirmado
Cegamiento	Doble ciego; comité independiente de seguridad y de adjudicación hepática.	Confirmado
Seguimiento	Respuesta a 24 semanas sin tratamiento; durabilidad pendiente.	Confirmado
Población	Sin cirrosis, con HBsAg ≤3,000, pocos HBeAg positivos y pocos pacientes negros o hispanos.	Reconocido por los autores
Financiamiento	GSK diseñó, vigiló y analizó; redactor médico pagado por GSK.	Confirmado
Aplicabilidad	Requiere HBsAg cuantitativo y vigilancia estrecha de ALT, plaquetas y función renal. Se excluyeron pacientes con vasculitis o autoinmunidad.	Interpretación editorial

7 Aprobación

El 20 de octubre de 2026 la FDA aprobó bepirovirsen junto con el tratamiento antiviral en adultos sin cirrosis, con ≥6 meses de antiviral, virus suprimido y HBsAg ≤3,000 UI/mL medido con una prueba autorizada, que se aprobó como diagnóstico acompañante. La etiqueta incluye un **recuadro de advertencia** por reacciones hepáticas graves y trombocitopenia, además de advertencias por deterioro renal y reacciones inflamatorias como vasculitis.

Pregunta de repaso: si ningún paciente con placebo logró la curación funcional, ¿el efecto de bepirovirsen es "infinito"?

Respuesta. No. Con placebo solo se podían suspender los AN si se perdía el HBsAg, lo que casi nunca ocurre con AN solos, así que el 0 % era esperable por diseño. Las medidas útiles son absolutas: ~1 de cada 5 pacientes tratados logró la curación funcional (1 de cada 4 con HBsAg ≤1,000), a cambio de eventos adversos grado ≥3 en 16 %. Y falta saber cuántos la mantienen a largo plazo.

¿Qué aprendí de medicina?

- 24 semanas de bepirovirsen lograron la **curación funcional en 19–20 %** (25–28 % con HBsAg ≤1,000).
- Solo para pacientes sin cirrosis, suprimidos y con HBsAg ≤3,000.
- Vigilar ALT, plaquetas, función renal y **vasculitis cutánea**.
- La durabilidad más allá de 24 semanas sin tratamiento está pendiente.

¿Qué aprendí de investigación?

- Revisa si el comparador **podía alcanzar** el desenlace.
- Ante 0 % en el control, usa cifras **absolutas**.
- Un desenlace de laboratorio necesita **durabilidad** para ser clínico.
- Dos ensayos idénticos consistentes = replicación interna.

8 Referencias

1. Hou J, Lim SG, Buti M, et al; B-Well Study Group. Phase 3 results of bepirovirsen treatment for chronic hepatitis B virus infection. *N Engl J Med*. 2026;394:2395-2406. doi:10.1056/NEJMoa2515131
2. Comunicado de aprobación de la FDA, 20 de octubre de 2026, según HCPLive: "FDA approves bepirovirsen for chronic hepatitis B".

Material educativo para profesionales de la salud. Elaborado con apoyo de inteligencia artificial y verificado contra el texto completo del artículo. DATO DEL ARTÍCULO = lo que reportan los autores; INTERPRETACIÓN = lectura editorial de Medicina en Resumen. No sustituye la lectura del artículo original ni el juicio clínico.